

# WHO 失智風險降低指南 - 醫療人員版

聲明版本：2026-07-23 | 閱讀本手冊前請先了解以下資訊

## 1. 內容性質與 AI 協作

本手冊為非營利衛教用途的中文知識轉譯、摘要與版面整理，不是 WHO 官方中文版，也未經 WHO 審核或背書。製作過程使用 OpenAI Codex 協助擷取原文、建立架構、產生中文初稿、改寫成不同受眾語言及排版；AI 可能產生誤譯、遺漏或過度簡化，使用者應回到英文原文核對。

## 2. 原始資料與權威版本

原著：World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines, second edition. Geneva: WHO; 2026. ISBN 978-92-4-012355-7。英文原版為具約束力及權威性的版本；WHO 網頁與原始檔案可能更新，請以官方出版頁的最新資訊為準。

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

## 3. 授權與分享條件

WHO 原著依 CC BY-NC-SA 3.0 IGO 授權。依 WHO 說明，非商業翻譯、重製及改作通常不需另行取得許可，但須正確標示 WHO 來源、授權與改作事實，不得暗示 WHO 認可任何個人、組織、產品或服務，且不得使用 WHO 標誌。本手冊新增的中文整理與改作部分以 CC BY-NC-SA 4.0 授權；第三方素材仍依各自權利。若用於收費、廣告導流、商業課程、產品宣傳或其他商業活動，應先另行確認或向 WHO 申請許可。

原著授權：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/>

本改作：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## 4. 醫療資訊與責任限制

本手冊僅供一般教育與知識分享，不構成診斷、治療、用藥或個別醫療建議，也不能取代醫療專業人員的判斷。任何健康決策都應依個人狀況與合格專業人員討論。若中文內容與英文原文不一致，以英文原文為準。

# 失智與認知退化 臨床完整摘要

建議、證據、解讀與落實

適用 | 醫師、護理師、藥師、復健、公衛與其他健康專業人員

修訂 | 2026-07-23 | 完整轉譯版

# 使用、授權與來源說明

先理解這份手冊能做什麼、不能做什麼。

降低風險不等於保證不會失智。本手冊不是診斷工具，也不取代個別醫療判斷；若有認知、情緒、睡眠或日常功能變化，應由合格專業人員評估。

## 原始文件

World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines, second edition. Geneva: WHO; 2026. ISBN 978-92-4-012355-7.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240123557>

## 轉譯與授權聲明

原作採 CC BY-NC-SA 3.0 IGO。本手冊為非商業、相同方式分享的繁體中文摘要與實務轉譯，未使用 WHO 標誌，也不暗示 WHO 背書。此翻譯 / 改作不是由 WHO 製作；WHO 不對翻譯內容或準確性負責，原始英文版為具約束力與真實性的版本。

## 頁碼如何對照

- 例如『p.20；PDF第46頁』：前者是書內印刷頁碼，後者是 PDF 閱讀器頁序。
- 每一主題末尾都標示主文件頁碼；細部 GRADE 表請再查 Web Annex。
- 本手冊新增的行動單、照護表與臨床流程會標為『轉譯工具』，不是 WHO 原文處方。

原文定位 | 版權頁：PDF第4頁；目錄 p.iii-v：PDF第5-7頁；主文件共168個PDF頁

# 原文導航與本手冊架構

依 WHO 主文件從頭到尾整理，附錄保留與使用者相關的重點。

| 原文章節      | 主題                | 原文範圍         |
|-----------|-------------------|--------------|
| 前言 / 摘要   | 背景、整體建議、執行考量      | p.vi、p.x-xxi |
| 第1章       | 脈絡、目的、範圍、對象       | pp.1-8       |
| 第2章       | 方法、GRADE、建議形成     | pp.9-16      |
| 第3.1節     | 6項健康行為            | pp.19-43     |
| 第3.2節     | 12項健康狀況與生物狀態      | pp.44-90     |
| 第3.3-3.4節 | 空氣污染、多領域介入        | pp.91-101    |
| 第4章       | 執行、研究、傳播、監測       | pp.102-105   |
| 附錄        | 範疇回顧、團隊、Web Annex | pp.116-140   |

本手冊不逐字翻譯原書168個PDF頁，而是完整保留與實務決策相關的內容層次：建議、理由、證據方向、備註、執行與缺口。作者名單及255筆參考文獻不逐項重印，改以原文頁碼、Web Annex與完整書目對照。

# 臨床閱讀框架

先區分疾病原適應症，再解讀失智特定建議與證據。

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>族群</b><br>正常認知 / MCI；年齡與生命歷程。 | <b>目的</b><br>疾病治療、整體健康，或失智特定風險降低。 |
| <b>證據</b><br>強度、確定性、直接結局與反向因果。   | <b>決策</b><br>共同決策、多領域整合、傷害與追蹤。    |

共同底線 | 『證據不足』不是『不要治療』；『條件式』不是『無效』；『強建議』也要看禁忌與安全。

## 1 | 指南背景、目的與適用範圍

為何要做、適用誰，以及哪些結論不能外推。

### 背景

失智是從先前功能水準下降、並顯著影響日常功能的一組疾病。2021年全球約5,700萬人罹患失智，逾60%居住在LMIC。因目前沒有廣泛可及的治癒或疾病修飾治療，跨生命歷程的風險降低是重要公共衛生策略。WHO 引述2024 Lancet Commission：最多約45%的失智風險可歸因於14項可調整因子；這是人口歸因概念，不是承諾45%個案一定可預防。

風險跨生命歷程累積；年齡也會改變關聯與反向因果



### 作用路徑

- 減少神經病理與血管傷害。
- 降低發炎與處理代謝功能失調。
- 增加神經韌性與認知 / 腦儲備。
- 降低壓力、社會孤立及感官負荷。

### 目的與範圍

指南要回答的是：已建立的風險因子若被治療或管理，是否直接降低認知退化 / 失智。它不取代每項疾病的現行臨床指引，也不是重新判定哪些暴露是風險因子。對象是尚未失智的成人，包括認知正常、MCI，以及兩者中同時有其他健康狀況者；新版也納入 HIV、TBI與中風相關失智風險。

生命歷程與反向因果 | 同一因子在不同年齡可能方向不同：中年肥胖是風險，但晚年體重下降可能是早期認知退化訊號；晚年新發憂鬱或睡眠變化也可能是前驅表現。

## 個人不能取代人口政策

教育、收入、健康食物、醫療可及、空品與安全活動環境受結構因素影響。只有個人衛教而沒有系統與政策支持，效果較小也較不公平。很多風險與 NCD 共通，因此應整合心血管、代謝、健康老化與社區方案。

原文定位 | WHO 2026, Foreword p.vi ; Executive summary p.x ; Introduction pp.1-8 ( PDF第27-34頁 )

# 2 | 指南如何形成建議

第二版遵循 WHO guideline handbook，使用 GRADE 與 Evidence-to-Decision。

## 參與與治理

WHO Steering Group由總部多部門與六區域辦公室組成；Guideline Development Group ( GDG ) 包含跨專業、跨地區及具生活經驗成員；另有5個證據回顧團隊、方法學家與外部同儕審查。利益衝突依 WHO 程序管理。

## 證據流程

- 先用範疇回顧檢查2019建議及新風險因子，判定哪些需完整更新。
- 以 PICO ( 族群、介入、比較、結果 ) 定義問題；系統性搜尋、綜整及評估偏差。
- GRADE 評估證據確定性；EtD 同時考慮效益傷害、價值偏好、資源、可接受性、可行性及公平性。
- GDG可確認既有、更新、新增、反對，或因證據不足不提出建議。

## 如何讀『強』與『條件式』

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 強建議  | 多數合適族群應接受 / 不接受；仍需留意禁忌與個別安全。 |
| 條件式  | 不同人可能做不同選擇；需共同決策並考量情境。       |
| 證據不足 | 無法對失智特定目的下結論，不表示原疾病不需治療。     |

指南的失智特定建議只評估認知 / 失智結局；每節旁列的通用 WHO 指引未被本次證據綜整改變。

原文定位 | WHO 2026, Methods pp.9-16 ( PDF第35-42頁 ) ; Recommendations p.18 ( PDF第44頁 )

### 3 | 全部建議總覽

先看方向，再到後續各節閱讀完整證據、備註與執行。

| 主題 / 類型            | 強度 / 確定性 / 頁碼         | 主題 / 類型                   | 強度 / 確定性 / 頁碼           |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 認知活動   更新建議        | 條件式 / 低   p.20-24     | 聽力損失管理   更新建議             | 條件式 / 低   p.60-63       |
| 認知活動   新增建議        | 條件式 / 極低   p.20-24    | 更年期荷爾蒙治療 ( MHT )   新增反對建議 | 反對 / 條件式 / 極低   p.64-67 |
| 社交活動   更新建議        | 條件式 / 極低   p.25-28    | 更年期荷爾蒙治療 ( MHT )   證據不足   | 證據不足 / -   p.64-67      |
| 身體活動   確認既有建議      | 強 / 中等   p.29-31      | 憂鬱管理   證據不足               | 證據不足 / -   p.68-71      |
| 身體活動   確認既有建議      | 條件式 / 低   p.29-31     | 腦中風管理   證據不足              | 證據不足 / -   p.72-75      |
| 減少有害飲酒   確認既有建議    | 條件式 / 中等   p.32-35    | 創傷性腦損傷 ( TBI )   證據不足     | 證據不足 / -   p.76-79      |
| 戒除菸草   確認既有建議      | 強 / 低   p.36-38       | 視力障礙管理   證據不足             | 證據不足 / -   p.80-82      |
| 健康均衡飲食與營養   更新建議   | 條件式 / 中等   p.39-43    | 睡眠管理   證據不足               | 證據不足 / -   p.83-86      |
| 健康均衡飲食與營養   確認反對建議 | 反對 / 強 / 中等   p.39-43 | 睡眠管理   證據不足               | 證據不足 / -   p.83-86      |
| 肥胖管理   更新建議        | 條件式 / 低至中等   p.45-48  | HIV 管理   證據不足             | 證據不足 / -   p.87-90      |
| 肥胖管理   新增建議        | 條件式 / 低至中等   p.45-48  | 降低空氣污染暴露   新增建議           | 條件式 / 極低   p.92-96      |
| 糖尿病管理   更新建議       | 條件式 / 極低   p.49-52    | 降低空氣污染暴露   新增建議           | 條件式 / 極低   p.92-96      |
| 高血壓管理   更新建議       | 條件式 / 極低   p.53-56    | 多領域介入   新增建議              | 條件式 / 中等至高   p.98-101   |
| 血脂異常管理   確認既有建議    | 條件式 / 低   p.57-59     |                           |                         |

#### 總覽的六個關鍵

- 強建議：認知正常成人身體活動；菸草使用者戒菸；無缺乏者不以特定補充品防失智。
- 條件式建議占多數，需依族群、偏好、安全、資源與公平性共同決策。
- MHT反對建議只限65歲以上停經女性，且只限單為防認知退化 / 失智的目的。
- 憂鬱、中風、TBI、視力、睡眠與HIV等『證據不足』，不影響它們原本應接受的標準照護。
- 空污是新版人口層級重點，家庭與環境暴露均為條件式、極低確定性。
- 多領域介入證據確定性中等至高，但認知效果多很小，仍為條件式且必須量身調整。

原文定位 | WHO 2026, Executive summary Table A p.xii-xx ( PDF第14-22頁 )

## 第3章 | 健康行為

以下各節依 WHO 原文順序，完整保留決策所需層次。

### 3.1.1 認知活動

範疇 / PICO | 認知正常或輕度認知障礙 ( MCI ) 成人：認知刺激 / 刺激性活動或認知訓練，相較一般照護或無介入，能否降低認知退化及 / 或失智風險？

#### WHO 通用指引

全生命歷程應促進早期培育互動、公平取得優質教育、具認知刺激的工作與環境，以及持續學習。

|      |                           |          |
|------|---------------------------|----------|
| 更新建議 | 認知訓練可考慮提供給認知正常或 MCI 的高齡者。 | 條件式 / 低  |
| 新增建議 | 可鼓勵參與認知刺激。                | 條件式 / 極低 |

#### 主要證據與理由

- 7篇系統性回顧納入 GRADE。認知訓練追蹤1-48週，可能小幅改善認知功能 ( Hedges' g 0.25 )，但5年失智發生率幾乎無差異 ( HR 1.00 )。
- 結構化認知刺激 ( 如桌遊，4-12週 ) 可能改善執行功能與語詞流暢度；整體認知與工作記憶不確定，未找到失智或 MCI 發生率證據。
- 日常刺激性活動的觀察研究顯示與較低失智或 MCI 風險及較佳認知相關 ( RR 約0.69-0.95 )，但確定性極低。

#### 解讀與備註

- 認知訓練是針對特定領域、重複且有目標的練習；認知刺激包含結構化團體方案，也包含閱讀、說故事、遊戲等日常活動。
- 新奇且具挑戰的活動可能同時改善情緒、生活品質與健康行為；真正重要的是認知獲益能否轉移到日常功能。
- 最佳類型、頻率、強度與持續時間尚無法確定。

#### 執行考量

- 以文化、語言與生活情境調整；透過圖書館、社區據點、學習中心與低 / 零成本活動降低交通、行動與經濟障礙。
- 可用團體、一對一、工作坊或數位平台交付，但需處理數位識能與設備不平等；整合進基層、社區與高齡服務並培訓人力。

#### 研究缺口

- 需要以失智發生率為結局的 RCT、較長追蹤、標準化介入與量測，以及能分離社交 / 運動共介入效果的設計。
- 需增加低中收入國家 ( LMIC )、不同性別、年齡、社經與 APOE 次群研究。

臨床決策轉譯 | 共同決策時說明短期認知測驗的小幅進步，不等同已證實降低長期失智發生率。

原文定位 | WHO 2026, 20-24 ( PDF第46-50頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.1.2 社交活動

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 成人：維持 / 促進高社交活動或預防社會孤立，是否優於一般照護或無介入？

#### WHO 通用指引

社會參與與全生命歷程的健康福祉密切相關，應依 WHO 指引予以支持。

|      |                           |          |
|------|---------------------------|----------|
| 更新建議 | 社交活動介入可考慮提供給認知正常或 MCI 成人。 | 條件式 / 極低 |
|------|---------------------------|----------|

#### 主要證據與理由

- 高社交參與的觀察證據與較低失智風險小幅相關 ( RR 0.81 ；低確定性 ) 。
- 認知正常高齡者的 RCT ( 6週至24個月 ) 顯示整體認知、記憶與執行功能可能有小幅改善；確定性極低至中等 ( SMD -0.25至0.40 ) 。
- MCI 僅一項 RCT：整體認知獲益可忽略、執行功能小幅改善 ( Cohen's d 0.04-0.24 ；極低確定性 ) 。

#### 解讀與備註

- 社會連結包含結構 ( 關係與互動數量 ) 、功能 ( 得到 / 感受到的支持 ) 及品質。
- 社會孤立是客觀的互動或關係不足；孤獨是期望與實際連結之間的主觀落差；不可混為一談。
- 研究介入包括團體休閒、志工、觀賽與線上互動；定義與測量差異很大。

#### 執行考量

- 強化社區網絡、代間活動、志工與同儕支持；方案需文化適切、包容、符合本人偏好。
- 同時處理交通、感官障礙、數位落差、照顧責任及社交焦慮；數位互動不能一律取代面對面連結。

#### 研究缺口

- 缺乏長期介入研究與失智發生率；最佳類型、頻率、強度及期間不明。
- 術語需標準化，並增加 LMIC、年輕族群、不同社經與數位 / 實體比較研究。

臨床決策轉譯 | 評估社會孤立與孤獨應分開；感官、憂鬱、行動與經濟障礙可能是可介入的上游因素。

原文定位 | WHO 2026, 25-28 ( PDF第51-54頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.1.3 身體活動

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 成人：身體活動介入是否優於一般照護或無介入？

#### WHO 通用指引

所有年齡與能力者均應規律活動，包括有氧、肌力與減少久坐，並依 WHO 身體活動指引執行。

|        |                          |         |
|--------|--------------------------|---------|
| 確認既有建議 | 認知正常成人應建議身體活動，以降低認知退化風險。 | 強 / 中等  |
| 確認既有建議 | MCI 成人可考慮身體活動，以降低認知退化風險。 | 條件式 / 低 |

#### 主要證據與理由

- 長期且較高活動量與較低認知退化、阿茲海默症及全因失智相關；本次範疇回顧認為新證據不太可能改變2019建議。
- 身體活動具廣泛健康效益、成本低且風險通常低；但正常認知與 MCI 的證據強度不同。
- 指南引述全球若身體不活動持續至2030年，將造成大量可預防 NCD 與成本；失智占案例比例較小但成本占比高。

#### 解讀與備註

- 建議與 WHO 有氧、阻力訓練及減少久坐的通用指引一致。



- 對已罹患失智者的 WHO mhGAP 另有活動建議；那是照護建議，勿和本指南的無失智 / MCI 族群混用。

### 執行考量

- 把個人諮詢與可步行環境、安全公共空間、社區方案及大眾傳播結合。
- 依能力、共病、跌倒風險與偏好調整；低資源地區可用社區與非專業人力支持。

### 研究缺口

- 仍需長期、直接以 MCI / 失智為結局的試驗，並釐清不同型態、劑量、年齡與次群反應。

臨床決策轉譯 | 正常認知為強建議；MCI 為條件式。處方應依一般身體活動指引、共病與安全個別化。

原文定位 | WHO 2026, 29-31 ( PDF第55-57頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

## 3.1.4 減少有害飲酒

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 且有酒精使用疾患者：行為與心理介入是否能降低認知退化或失智風險？

### WHO 通用指引

酒精具精神活性、毒性與依賴性；不應以任何飲酒量作為健康建議。

|        |                                  |          |
|--------|----------------------------------|----------|
| 確認既有建議 | 可提供減少或停止高風險 / 有害飲酒的介入，包含支持酒精依賴者。 | 條件式 / 中等 |
|--------|----------------------------------|----------|

### 主要證據與理由

- 過量飲酒及酒精使用疾患與認知障礙和失智相關；酒精的多器官危害及癌症、心血管疾病、傷害風險支持預防原則。
- 人口證據不支持輕度或中度飲酒具有淨健康保護效果；失智的精確因果路徑仍待釐清。
- 具成本效益的方法包括篩檢、短暫介入，以及在基層提供連續、循證的心理社會與藥物治療。

### 解讀與備註

- 不要用『喝一點保護大腦』作健康建議。行為介入一般接受度及安全性較高，但依賴者可能需要專業藥物與營養支持。
- 個人介入需與稅制、限制可得性與廣告、酒駕執法等 SAFER 政策並行。

### 執行考量

- 把篩檢與短暫介入整合進基層；使用諮商、動機式晤談及依賴治療。
- 酒精依賴治療可含硫胺素營養支持與循證藥物；LMIC 可培訓社區工作者與非專科人力。

### 研究缺口

- 重度飲酒與使用疾患者及年輕族群常被排除；需要生命歷程、客觀且反覆的暴露量測。
- 需釐清劑量、機制、飲品型態的混雜及健康存活者偏差。

臨床決策轉譯 | 以標準化篩檢、brief intervention與治療轉介整合基層；依賴處置需考量戒斷安全與硫胺素。

原文定位 | WHO 2026, 32-35 ( PDF第58-61頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.1.5 戒除菸草

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 的菸草使用者：戒菸介入是否優於一般照護或無介入？

#### WHO 通用指引

應完全避免菸草；使用者應獲循證行為及藥物戒除支持，所有人應免受二手菸暴露。

|        |                  |       |
|--------|------------------|-------|
| 確認既有建議 | 應向使用菸草的成人提供戒菸介入。 | 強 / 低 |
|--------|------------------|-------|

#### 主要證據與理由

- 所有形式菸草皆有害，沒有安全暴露量；中年吸菸對日後失智風險尤其重要。
- 大型世代顯示戒菸時間可能重要：持續戒除較久者的風險可接近從不吸菸者；單純減量未呈現同樣一致的風險下降。
- WHO 引述菸草每年造成逾700萬可歸因死亡；範疇回顧認為既有建議無需改變。

#### 解讀與備註

- 戒得越早越有利，但任何階段戒菸仍有益；需依 WHO 成人戒菸臨床指引。
- 新型菸品、電子煙與加熱菸的失智風險資料仍不足。

#### 執行考量

- 基層增加篩檢、諮商與藥物支持，特別關注35-65歲；整合 NCD 與心理健康服務。
- 稅制、禁廣告、圖像警示、無菸法律及教育需與個人戒菸服務互補。

#### 研究缺口

- 需釐清血管、氧化壓力及神經退化機制；改善自陳暴露偏差與存活者偏差。
- 需研究停止時機、減量強度與新型尼古丁產品。

臨床決策轉譯 | 強建議但證據確定性低；依 WHO 戒菸指引結合行為與藥物治療，不以單純減量替代戒除目標。

原文定位 | WHO 2026, 36-38 ( PDF第62-64頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.1.6 健康均衡飲食與營養

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 成人：健康飲食型態（如地中海飲食）是否優於一般照護或無介入？

#### WHO 通用指引

所有成人應採健康均衡飲食：足夠、均衡、多樣、適量，並依個人、文化與在地食物調整。

|        |                                                    |             |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|
| 更新建議   | 健康、均衡的飲食型態可考慮提供給認知正常或 MCI 成人。                      | 條件式 / 中等    |
| 確認反對建議 | 無已確立缺乏者，不建議為降低風險補充維生素B、E、omega-3 PUFA及綜合維生素 / 礦物質。 | 反對 / 強 / 中等 |

#### 主要證據與理由

- 2篇系統性回顧：MeDi、DASH、MIND 或低碳水介入，最長13-37個月；整體認知或處理速度可能小幅改善（SMD 約0.05-0.30），執行 / 空間功能多為無或不確定。
- MeDi 單獨分析較可能小幅改善認知與處理速度；仍無失智或 MCI 發生率證據，因此不推薦唯一特定飲食。
- 全飲食型態可能比單一營養素更相關；補充品反對建議只適用於未診斷營養缺乏者。

#### 解讀與備註

- MeDi偏植物、橄欖油、適量魚禽乳品、少紅肉與糖；DASH減鹽、添加糖與飽和脂肪；MIND結合兩者並強調莓果與綠葉菜。
- 核心原則可文化在地化；高齡者仍需確保蛋白質等重要營養。

執行考量

- 用在地可取得、可負擔食物轉譯核心原則；以財政與食物環境政策支持，而非只責怪個人。
- 強調長期全飲食與持續行為支持，不以單一『神奇食物』取代。

研究缺口

- 需研究非地中海文化的區域性、植物性及新興飲食，並直接評估 MCI / 失智。
- 增加 LMIC、性別、年齡、APOE、成本與可及性研究。

臨床決策轉譯 | 補充品反對建議有明確例外：已診斷缺乏者。飲食建議不指定唯一型態，重點是全飲食品質與可持續性。

原文定位 | WHO 2026, 39-43 ( PDF第65-69頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

第3章 | 健康狀況與生物狀態

以下各節依 WHO 原文順序，完整保留決策所需層次。

3.2.1 肥胖管理

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 的過重 / 肥胖成人：減重或肥胖控制是否優於一般照護或無介入？

WHO 通用指引

所有非孕period肥胖成人應依 WHO

指引獲得管理；肥胖是受生物、行為、食物環境與市場等交互影響的慢性復發性疾病。

|      |                   |            |
|------|-------------------|------------|
| 更新建議 | 可考慮降低中年期過重或肥胖。    | 條件式 / 低至中等 |
| 新增建議 | 過重或肥胖成人可考慮飲食限制介入。 | 條件式 / 低至中等 |

主要證據與理由

- 全球約43%成人過重、16%肥胖；中年肥胖與腰圍增加和較高失智風險相關。
- 1篇系統性回顧涵蓋熱量限制及間歇性斷食：認知正常成人6-17個月可能小幅改善記憶、整體認知與注意 ( SMD 0.18-0.35 ) 。
- 未找到失智 / MCI 發生率、MCI族群、GLP-1、手術或其他減重策略的合格直接證據。

解讀與備註

- 腰臀比有時比 BMI 更能反映中央肥胖；肥胖不應被簡化為個人意志問題。
- 晚年體重下降可能是早期認知變化的結果；中年風險不可直接外推為高齡者都應減重。

執行考量

- 由訓練人員提供飲食、活動、心理及必要藥物等多面向支持，處理食物與服務可及性。
- 高齡者使用飲食限制需謹慎並持續監測安全、營養與功能。

研究缺口

- 缺乏直接失智結局、其他減重方式、藥物 ( 含GLP-1 ) 、年齡 / 性別 / 社經次群及成本效益資料。

臨床決策轉譯 | 區分中年風險介入與晚年反向因果。現有直接證據主要限於飲食限制的短期認知結果。

原文定位 | WHO 2026, 45-48 ( PDF第71-74頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.2.2 糖尿病管理

範疇 / PICO | 糖尿病且認知正常或 MCI 成人：藥物降糖及 / 或飲食運動是否降低認知退化 / 失智風險？

#### WHO 通用指引

所有糖尿病成人都應依 WHO HEARTS D、PEN 與糖尿病計畫接受管理。

|      |                                 |          |
|------|---------------------------------|----------|
| 更新建議 | 糖尿病成人可考慮糖尿病管理，以降低認知退化及 / 或失智風險。 | 條件式 / 極低 |
|------|---------------------------------|----------|

#### 主要證據與理由

- 全球約8.3億人有糖尿病，95%以上為第2型；第2型糖尿病者失智風險約高50-100%。
- 9篇系統性回顧：T2D合併MCI者的運動可能改善認知（SMD 0.65-0.91；中等），認知正常者較不確定。
- 強化血糖控制相較標準控制，對失智（RR 1.27）與認知（ $\beta=-0.03$ ）可能幾乎無差異；DPP-4與GLP-1的認知訊號確定性極低，不足以作特定選藥。

#### 解讀與備註

- 有效血糖控制、健康飲食、活動、體重與戒菸，以及完整心血管風險管理，仍是糖尿病照護核心。
- 失智特定證據極低，不代表標準糖尿病治療缺乏效益。低血糖本身也可能累積認知風險。

#### 執行考量

- 利用既有基層與 NCD 平台，確保藥物、監測工具與訓練人力；可用社區工作者、遠距及提醒工具。
- 整合健康老化與多領域介入，並避免數位工具擴大不平等。

#### 研究缺口

- 需直接以失智 / MCI為結局、比較特定降糖藥與治療強度、納入低血糖與生命歷程。
- 非運動生活介入、MCI、LMIC與多元次群不足。

臨床決策轉譯 | 避免把極低確定性解讀為應強化血糖到不安全目標；藥物與目標仍依糖尿病指引及低血糖風險。

原文定位 | WHO 2026, 49-52 ( PDF第75-78頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.2.3 高血壓管理

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 的高血壓成人：治療高血壓是否降低認知退化 / 失智風險？

#### WHO 通用指引

所有高血壓成人應依 WHO 成人高血壓藥物治療與 HEARTS 指引接受管理。

|      |                                 |          |
|------|---------------------------------|----------|
| 更新建議 | 高血壓成人可考慮高血壓管理，以降低認知退化及 / 或失智風險。 | 條件式 / 極低 |
|------|---------------------------------|----------|

#### 主要證據與理由

- 30-79歲成人約三分之一有高血壓；三分之二居住在 LMIC，且常未診斷或未充分治療。
- 高血壓是確立的失智風險因子，尤其生命歷程中的中年暴露；治療研究的認知 / 失智結果不一致且受追蹤與設計限制。
- 降壓治療有明確心血管效益；本指南的條件式建議僅評估額外的認知 / 失智結果。

#### 解讀與備註

- 需控制但避免因過度降壓造成暈眩、跌倒或灌流問題；目標依現行高血壓指引及個人風險。
- 血壓與認知可能受年齡、病程及反向因果影響，不能以晚年單次血壓推論終生風險。

#### 執行考量

- 加強基層篩檢、可負擔藥物、標準化治療流程與追蹤；整合 NCD 與腦健康。

- 處理服藥取得、健康識能、居家監測與照護協調。

研究缺口

- 需更長期、以失智為結局、比較年齡、目標與藥物類別的研究，並增加 LMIC與次群資料。

臨床決策轉譯 | 治療依高血壓指引；失智特定證據極低，應兼顧心血管獲益、衰弱與不良事件。

原文定位 | WHO 2026, 53-56 ( PDF第79-82頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

3.2.4 血脂異常管理

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 的血脂異常成人：治療血脂是否降低認知退化 / 失智風險？

WHO 通用指引

所有血脂異常成人應依 WHO HEARTS 風險導向心血管管理與 NCD 指引處理。

|        |                                |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| 確認既有建議 | 中年期可考慮管理血脂異常，以降低認知退化及 / 或失智風險。 | 條件式 / 低 |
|--------|--------------------------------|---------|

主要證據與理由

- 中年期高血脂與失智風險相關；高膽固醇可能經由中風、血管傷害及 tau / amyloid相關路徑影響。
- 觀察研究顯示 statin 與較低失智風險相關，但長期安慰劑 RCT 在實務與倫理上困難，因此因果證據有限。
- 管理血脂的主要適應症仍是心血管風險降低，不應只以失智預防決定是否治療。

解讀與備註

- 建議明確聚焦中年期；晚年脂質與認知關係更複雜。
- 依整體心血管風險、共病、藥物效益與不良反應共同決策。

執行考量

- 整合基層心血管風險評估、可及藥物、健康行為與長期追蹤。

研究缺口

- 需較好的生命歷程、藥物類別、劑量、依從與不同族群研究；直接失智結局仍有限。

臨床決策轉譯 | 條件式建議聚焦中年；依 CVD 風險指引處置，避免以觀察性防失智訊號作唯一開藥理由。

原文定位 | WHO 2026, 57-59 ( PDF第83-85頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

3.2.5 聽力損失管理

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 且有聽損成人：聽力治療是否降低認知退化或失智風險？

WHO 通用指引

應依 WHO 指引預防、篩檢與管理聽力損失。

|      |                 |         |
|------|-----------------|---------|
| 更新建議 | 聽力損失成人可考慮提供助聽器。 | 條件式 / 低 |
|------|-----------------|---------|

主要證據與理由

- 全球約五分之一有某種聽損；未處理聽損影響溝通、關係與心理健康。
- 2篇系統性回顧：觀察資料顯示助聽器與較低失智 / MCI風險相關 ( HR 0.73-0.83 ；極低 ) ；RCT對認知功能僅小幅效果 ( SMD 0.11 ；極低 ) 。
- 未有足夠人工電子耳對失智風險的證據。

解讀與備註

- 聽損可能透過社交減少、認知負荷、心血管及神經生物路徑影響。
- 助聽器首先是處理聽損、改善溝通與生活品質，不應只為防失智而使用；效果受嚴重度與實際使用影響。

執行考量

- 超過4億人可能受益於聽覺裝置，但需求僅約17%獲滿足；需處理污名、費用、延遲、維修及人力。
- WHO建議50歲以上系統性篩檢與及時診斷配戴；可整合基層、認知篩檢與轉介，並預防噪音及耳部感染。

研究缺口

- 需長期 RCT、MCI、中年介入、聽損嚴重度 / 側別及人工電子耳資料；LMIC不足。

臨床決策轉譯 | 助聽器為條件式 / 低；以聽力適應症為主，提供配戴支持並建立聽力與認知雙向轉介。

原文定位 | WHO 2026, 60-63 ( PDF第86-89頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

3.2.6 更年期荷爾蒙治療 ( MHT )

範疇 / PICO | 卵巢早衰、早發 / 圍 / 停經且認知正常或 MCI 女性：目前或過去 MHT 是否影響認知退化 / 失智風險？

WHO 通用指引

MHT 主要用於血管舒縮症狀及停經泌尿生殖症候群，不是失智預防。

|        |                                         |               |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 新增反對建議 | 65歲以上停經女性，不建議單為降低認知退化及 / 或失智風險而使用 MHT。  | 反對 / 條件式 / 極低 |
| 證據不足   | 65歲以下 ( 含卵巢早衰、早發停經、圍停經 ) 無法支持或反對為此目的使用。 | 證據不足 / -      |

主要證據與理由

- 10項研究 ( 1 RCT、9觀察 )。65歲以上試驗：單用雌激素或雌激素加黃體素對失智可能幾乎無差異；觀察結果不確定。
- 證據可支撐的族群主要是65歲以上，並非最常開始 MHT 的年齡；較早年齡與現代配方資料不足。
- 年齡、開始時間、配方、療程、給藥途徑與健康狀況異質，不能廣泛外推。

解讀與備註

- 65歲以上的反對建議不論 MHT 類型，且只針對防認知退化 / 失智目的。
- MHT 對症狀、骨折與其他風險的完整利弊另需評估；開始距停經超過10年時效益風險通常較不利。

執行考量

- 本人與臨床人員共同討論症狀治療效益、血栓、中風、癌症等風險，特別是65歲以上或長期使用者。
- 避免把女性較高失智負擔簡化為荷爾蒙單一因素；需同時考量生物、社會與環境決定因子。

研究缺口

- 現代配方、65歲以下、卵巢早衰、早發停經、不同途徑 / 療程、APOE及多元地區資料不足；critical window假說未確認。

臨床決策轉譯 | 反對建議限65歲以上且限防失智目的；勿外推到40-50歲典型症狀治療族群。

原文定位 | WHO 2026, 64-67 ( PDF第90-93頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex



### 3.2.7 憂鬱管理

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 且有憂鬱 / 症狀成人：治療相較一般照護、安慰劑或無介入，能否降低風險？

#### WHO 通用指引

所有憂鬱成人應依 WHO mhGAP 以心理介入及 / 或抗憂鬱藥治療。

|      |                                           |          |
|------|-------------------------------------------|----------|
| 證據不足 | 若目的僅為降低認知退化及 / 或失智風險，目前無法建議憂鬱管理。憂鬱本身仍應治療。 | 證據不足 / - |
|------|-------------------------------------------|----------|

#### 主要證據與理由

- 2篇系統性回顧，主要為觀察研究。抗憂鬱藥對失智 / MCI呈小幅負向或無效果（RR 1.04-1.21；極低）；非藥物介入對 MCI 認知小幅或可忽略。
- 缺乏直接評估治療對失智 / MCI的RCT；憂鬱與認知可能雙向，晚年新發症狀也可能是前驅表現。
- 治療仍可改善情緒、功能與生活品質，不能因防失智證據不足而不治療。

#### 解讀與備註

- 老年憂鬱與認知障礙可同有記憶、注意、冷漠與退縮；需結構化評估心情、認知與功能。
- 藥物需要時，優先較低抗膽鹼負荷；三環抗鬱劑與 paroxetine 通常應避免，並監測低血鈉、QTc、姿勢性低血壓及跌倒。

#### 執行考量

- 整合基層篩檢、心理介入、藥物檢視、神經 / 老年 / 精神與社區服務；新發老年憂鬱可考慮神經與神經心理評估。
- 在資源不足地區培訓非專科人力，降低污名並提供文化適切服務。

#### 研究缺口

- 需 RCT、生命歷程、共病與次群研究，並釐清與活動、睡眠、社交的交互作用。

臨床決策轉譯 | 證據不足不是反對。新發老年憂鬱需鑑別前驅認知變化；用藥時降低抗膽鹼負荷並定期 review。

原文定位 | WHO 2026, 68-71 ( PDF第94-97頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.2.8 腦中風管理

範疇 / PICO | 缺血性中風 / TIA史成人：治療缺血或預防復發的介入能否降低認知退化或失智風險？

#### WHO 通用指引

所有腦中風成人仍應依 WHO 指引接受急性治療、二級預防與復健。

|      |                                             |          |
|------|---------------------------------------------|----------|
| 證據不足 | 若目的僅為降低認知退化及 / 或失智風險，無法對常用的預防再中風藥物介入提出特定建議。 | 證據不足 / - |
|------|---------------------------------------------|----------|

#### 主要證據與理由

- 2021年全球約9,380萬中風個案；反覆缺血性中風者的失智發生率約為首次中風者1.5倍。
- 1篇系統性回顧：降壓、抗血栓與降脂策略對失智 / 認知多為小或無差異，部分策略增加嚴重不良事件；研究樣本、結果與確定性不一致。
- 本次證據只涵蓋藥物防復發；認知復健等非藥物介入不在 PICO 範圍。

#### 解讀與備註

- 中風仍是重要風險；快速再灌流、適當抗血栓、血壓血脂控制與復健有其明確原適應症。
- 控制高血壓、糖尿病、房顫、吸菸、空污及活動等共同風險，對血管與腦健康重要。

執行考量

- 把認知評估與個別復健納入中風照護路徑；訓練中風單位辨識認知障礙並長期追蹤。
- 強化 LMIC 基層與轉介；遠距復健可補可及性，但需處理數位障礙。

研究缺口

- 需以失智為主要結局的 RCT、多專業復健、不同中風型態、影像指標、年齡 / 性別 / APOE及LMIC研究。

臨床決策轉譯 | 本 PICO  
限藥物二級預防的認知 / 失智結局；標準中風治療與二級預防照常依指引。

原文定位 | WHO 2026, 72-75 ( PDF第98-101頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

3.2.9 創傷性腦損傷 ( TBI )

範疇 / PICO | TBI後藥物或非藥物介入，相較無介入 / 一般治療，能否降低後續認知退化 / 失智？

WHO 通用指引

各族群應落實頭部傷害與 TBI 預防，並依 WHO 的復健、安全帽、道路安全及暴力預防資源。

證據不足

若目的僅為降低認知退化及 / 或失智風險，TBI後目前無法建議特定介入。

證據不足 / -

主要證據與理由

- 2021年約3,800萬人帶有 TBI 長期影響，年發生約2,100萬；大型世代與手足控制研究一致顯示 TBI 增加失智風險。
- 8項研究涵蓋ACE抑制劑、statin、metformin、sertraline與復健等；部分觀察訊號顯示較低風險，但證據極低且不一致。
- 缺乏足以支持特定藥物、手術或復健方案作防失智用途的資料。

解讀與備註

- 優先預防道路、運動、工作與暴力造成的頭部傷害；女性可能因親密伴侶暴力而被低估。
- TBI後的急性治療、症狀處理及復健仍依臨床需要，不受本項證據不足影響。

執行考量

- 藥物處理一般較可及；認知復健資源需求較高，需依資源與功能需求配置。
- 整合安全帽、防跌、運動腦震盪識別、暴力預防與可近復健。

研究缺口

- 需長期、標準化TBI嚴重度與重複傷害、女性、LMIC、年齡、APOE及功能結局研究。

臨床決策轉譯 | 現有藥物訊號不足以改變 TBI 標準照護；記錄傷害次數、嚴重度及功能，關注 IPV 相關漏診。

原文定位 | WHO 2026, 76-79 ( PDF第102-105頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex



### 3.2.10 視力障礙管理

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 且有視損成人：治療視損是否降低認知退化或失智風險？

#### WHO 通用指引

所有疑似視損成人應篩檢；確診者應依 WHO 眼科與 ICOPE 指引管理。

|      |                                  |          |
|------|----------------------------------|----------|
| 證據不足 | 若目的僅為降低認知退化及 / 或失智風險，無法建議特定視力介入。 | 證據不足 / - |
|------|----------------------------------|----------|

#### 主要證據與理由

- 全球逾22億人有近 / 遠視力障礙，50歲以上盛行較高；可能透過神經退化、感官輸入減少、社會孤立與認知負荷相關。
- 2篇系統性回顧主要評估白內障手術：失智風險 HR 0.81、認知 SMD 0.14 的小幅正向訊號，但確定性極低。
- 觀察設計、選擇偏差與健康照護利用差異限制因果推論。

#### 解讀與備註

- 視力治療可改善視覺功能、安全、獨立與生活品質，即使防失智證據不足。
- 感官問題可能使認知測驗失真；評估時需確保看得到材料與指示。

#### 執行考量

- 把視力篩檢、可負擔眼鏡、白內障服務與基層 / 高齡整合照護連結。
- 處理費用、交通、等待與人力，並提供適合感官障礙的認知工具。

#### 研究缺口

- 需介入研究、MCI、不同眼疾 / 治療、長期失智結局與 LMIC資料。

臨床決策轉譯 | 白內障手術訊號為極低確定性，不足以宣稱防失智；視力適應症與功能獲益仍成立。

原文定位 | WHO 2026, 80-82 ( PDF第106-108頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

### 3.2.11 睡眠管理

範疇 / PICO | 睡眠-覺醒障礙成人：治療是否降低風險？以及一般成人改善品質、時數、連續性與深度是否降低風險？

#### WHO 通用指引

良好睡眠有益整體健康，包括足夠時數、連續不受干擾及具恢復性的深睡；個別需求不同。

|      |                                        |          |
|------|----------------------------------------|----------|
| 證據不足 | 若目的僅為降低認知退化 / 失智風險，無法建議治療睡眠-覺醒障礙。      | 證據不足 / - |
| 證據不足 | 若目的僅為降低認知退化 / 失智風險，無法建議改善睡眠品質或時數的特定介入。 | 證據不足 / - |

#### 主要證據與理由

- 失眠、短 / 長睡眠、品質差、白天嗜睡與睡眠呼吸障礙都與認知退化 / 失智相關，但反向因果可能存在。
- 5篇系統性回顧：失眠藥物對最長6個月認知測驗可能小幅改善 ( SMD 0.05-0.72 ) ；OSA的CPAP可能改善執行功能 ( SMD 0.09-0.93 ) 。
- 沒有系統性回顧直接顯示介入降低失智或 MCI 發生率；整體低至極低確定性、短期且效果不一致。

#### 解讀與備註

- 睡眠障礙包括失眠、嗜睡、呼吸、晝夜節律、動作及異睡症等，不能用單一時數處理。
- 睡眠變化也可能是神經退化前驅；需辨識原發睡眠問題與早期認知改變。

執行考量

- 基層使用文化適切篩檢與轉介；改善臥室噪音、光與熱，並提供睡眠教育。
- 數位 CBT / 穿戴裝置可增加可及性，但需驗證與保護資料；建立睡眠與記憶門診轉介。

研究缺口

- 需大型長期 RCT、客觀量測、失智 / MCI 結局，以及最佳品質 / 時數門檻。

臨床決策轉譯 | 評估

OSA、藥物、情緒、疼痛與前驅神經退化；不要把短期認知測驗改善等同防失智。

原文定位 | WHO 2026, 83-86 ( PDF第109-112頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

3.2.12 HIV 管理

範疇 / PICO | 接受 ART 的 HIV 成人：改變 ART 或其他介入能否降低認知退化 / 失智或改善認知？

WHO 通用指引

所有 HIV 感染者不論臨床期與 CD4，均應快速開始 ART、維持病毒抑制並依 WHO 指引管理。

證據不足

無足夠證據為降低認知退化 / 失智而優先選特定 ART 組合；依疾病控制需求與病人偏好選擇。

證據不足 / -

主要證據與理由

- 全球近4,100萬 HIV 感染者，三分之二在 LMIC；ART 大幅降低嚴重神經併發與 HIV 相關失智，但較輕認知障礙仍常見 ( 估計39.6% )。
- 5項研究多為現今不常用的 ART 調整；maraviroc intensification有一項認知正向訊號 ( d=0.55 )，但確定性極低且成本 / 可及性差。
- 無合格非藥物介入、無失智或 MCI 發生率資料；不能指定對認知最佳 ART。

解讀與備註

- ART透過抑制中樞病毒複製與神經發炎保護腦健康；殘存認知問題可能反映既有神經損傷。
- 某些 ART 可能具劑量相關神經副作用，選擇仍依最新版 HIV 指引、抗藥性、共病與偏好。

執行考量

- 優先病毒抑制、快速啟動、機會性感染處置與遵從支持；納入年輕 HIV 成人。
- 整合 HIV 與認知服務；高風險或有症狀者可文化適切篩檢，處理污名、polypharmacy與可及性。

研究缺口

- 需長期認知 / 功能 / 生活品質及失智結局、非藥物介入、LMIC、多元次群與機制研究。

臨床決策轉譯 | 不以 CNS penetration 或單一認知訊號自行偏離 WHO ART 指引；評估病毒控制、共病、藥物與 legacy injury。

原文定位 | WHO 2026, 87-90 ( PDF第113-116頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

## 第3章 | 環境風險

以下各節依 WHO 原文順序，完整保留決策所需層次。

### 3.3.1 降低空氣污染暴露

範疇 / PICO | 人口層級：降低家庭空污或環境 PM2.5、PM10、CO、NO2、NOx，是否降低認知退化 / 失智？

#### WHO 通用指引

空污具毒性；全生命歷程降低室內外暴露對整體健康重要，應依 WHO 全球空氣品質指引。

|      |                                            |          |
|------|--------------------------------------------|----------|
| 新增建議 | 降低家庭空氣污染可能降低認知退化及 / 或失智風險或發生率。             | 條件式 / 極低 |
| 新增建議 | 降低環境空污，尤其PM2.5，可能降低認知退化及 / 或失智風險或發生率。<br>。 | 條件式 / 極低 |

#### 主要證據與理由

- 99%全球人口受到環境或家庭空污影響；PM2.5可跨越血腦障壁，引發神經發炎與氧化壓力。
- 14篇系統性回顧：PM2.5與失智 ( HR 1.40 ) 及認知下降 ( OR 1.35 ) 相關；NOx與失智 HR 1.14，但偏差與不精確使確定性低。
- 固體燃料烹調與 MCI ( HR 1.31 ) 及較差認知相關；改用電力 / 燃氣等清潔燃料可能有益，但屬觀察證據。

#### 解讀與備註

- 環境 RCT 因倫理與實務困難，傳統 GRADE 會使確定性偏低；跨地區一致性、生物合理性與疾病負擔仍支持條件式建議。
- 乾淨空氣是社會責任，不應全推給個人；污染對低收入與邊緣族群不成比例。

#### 執行考量

- 公共衛生、環境、交通與能源跨部門合作；針對工業區、都會及脆弱族群。
- 監測空品與認知健康，評估清潔能源、交通排放與都市規畫政策。

#### 研究缺口

- 需自然實驗 / 準實驗、介入前後認知與失智結局、家庭燃料轉換及 LMIC研究。

臨床決策轉譯 | 把環境暴露納入社會史與衛教；避免以極低確定性否認空污的一般健康危害與政策價值。

原文定位 | WHO 2026, 92-96 ( PDF第118-122頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

## 第3章 | 多重風險

以下各節依 WHO 原文順序，完整保留決策所需層次。

### 3.4.1 多領域介入

範疇 / PICO | 認知正常或 MCI 成人：同時處理三項以上風險的多領域介入，是否優於一般照護、低強度或無介入？

#### WHO 通用指引

多個風險常共存並跨生命歷程累積，應整體處理。

|      |                               |            |
|------|-------------------------------|------------|
| 新增建議 | 可考慮提供量身調整、同時處理三項以上風險因子的多領域介入。 | 條件式 / 中等至高 |
|------|-------------------------------|------------|

#### 主要證據與理由

- WHO新作系統性回顧與統合分析納入2012-2025年44項RCT，成分含活動、認知、憂鬱、飲食、代謝 / 血管、社交與戒菸。
- 認知正常 / 高風險者：高確定性顯示失智發生率幾乎無差異，認知各領域呈一致但極小效果 ( SMD 0.01-0.08 )。
- MCI / 前驅阿茲海默症：多項認知結果從可忽略到小幅獲益 ( SMD 0.00-0.18 )，確定性極低至高；CDR sum of boxes無效果 ( 高 )。

#### 解讀與備註

- 量身調整是依實際風險、偏好、文化、經濟與資源選擇成分、強度與交付方式；不是固定套餐。
- 小效果若大規模實施仍可能有公共衛生價值，且可帶來 NCD 與功能的額外效益；MCI可能獲益較多但仍屬 modest。

#### 執行考量

- 優先有可調整風險者；整合既有基層、NCD、健康老化與社區平台，培訓醫療與社區人力。
- 數位 / 混合模式可擴展但需數位識能、可及性、資料保護與倫理；政策支持安全活動空間及健康食物。

#### 研究缺口

- 44項試驗僅2項納入失智發生率、無 MCI發生率；需長期臨床結局、最佳劑量、遵從量測、風險分數與生物標記驗證。
- 增加 LMIC、性別、年齡、APOE與成本研究。

臨床決策轉譯 | 證據確定性最高不代表效果大；結果多為極小認知效果，建議仍條件式。應以整體健康與個人優先順序共同決策。

原文定位 | WHO 2026, 98-101 ( PDF第124-127頁 ) ；細部 Evidence profile / EtD 見對應 Web Annex

# 4 | 跨領域執行與未來方向

有效且公平的落實，需要超越個人行為改變。

## 4.1 跨切執行考量

- 處理結構與政策障礙：必要藥物與輔具、健康食物負擔、安全活動空間及空污。
- 所有工具與方案需文化及情境調整，特別重視高齡、偏鄉、低社經與 LMIC。
- 跨部門與跨專業合作；同時處理多重風險，並整合基層、NCD、老化與社區平台。
- 數位與面對面並用；數位能擴大觸及，但不能取代對數位弱勢者的重要服務。
- 建立人力能力、公共認知與去污名；持續監測、評估與環境暴露監測。

## 4.2 共同證據缺口

- 多為觀察研究，RCT較少，GRADE常為低或極低。
- 失智 / MCI很少是主要結局，追蹤常太短。
- 高收入國家占多數；年齡、性別、社經與遺傳次群不足。
- 介入與結局定義不一致，多風險交互作用未充分研究。
- 可行性、擴展性、成本效益、政策效果與替代結局驗證不足。

## 4.3 傳播與衍生產品

WHO將製作六種聯合國官方語言的執行摘要（視資源）、政策簡報、Q&A、訓練、工作坊與衍生工具；各國需在WHO區域與國家辦公室支持下調整並整合進健康系統。2019版材料應更新以符合第二版。

## 4.4 監測與評估

WHO將蒐集執行者與專家回饋，評估採用、實用性與影響，並運用 Global Dementia Observatory、延長至2031年的全球失智行動計畫、心理健康與 NCD 行動計畫指標。

原文定位 | WHO 2026, pp.102-105 ( PDF第128-131頁 )

## 本手冊轉譯工具 | 執行檢核

- □ 區分原適應症與失智特定目的。
- □ 條件式建議完成共同決策並記錄價值偏好。
- □ 多領域方案至少三項且依實際風險量身調整。
- □ 追蹤獲益、傷害、負擔、遵從與功能，不只認知分數。
- □ 品質監測包含觸及、公平性、轉介完成與不良事件。

## 臨床紀錄與品質指標

| 層級 | 最低紀錄項目                   | 可監測指標            |
|----|--------------------------|------------------|
| 個人 | 認知狀態、實際風險、治療目的、偏好、障礙與安全  | 目標達成、功能、不良事件、遵從  |
| 服務 | 篩檢、轉介、共同決策、多領域成分與追蹤責任    | 轉介完成率、持續率、等待時間   |
| 系統 | 人力、藥物 / 輔具、數位與面對面可及、社區夥伴 | 族群觸及、公平差距、成本與擴展性 |

風險溝通句型 | 『這項處置對 \_\_ 疾病 / 功能有既定目的；對額外降低失智風險的證據是 \_\_ 。因此我們會依你的優先順序與安全，選擇 \_\_ 並追蹤 \_\_ 』。

# 附錄 | 範疇回顧與 Web Annex 導航

主文件後段如何支撐第二版更新。

## Annex 1：範疇回顧

WHO以範疇回顧判定2019既有建議是否需完整更新，並辨識新風險因子。結果使5項既有建議被確認，8項既有 / 先前證據不足主題進行完整綜整，另有8項新風險納入。附錄列出搜尋方法、納入的系統性回顧與各風險因子證據變化；它不是取代各 Web Annex 的完整 GRADE。

## Annex 2：指南發展團隊

列出 WHO Steering Group、GDG、證據回顧團隊、方法學家與外部審查者。團隊涵蓋六區域、多專業及生活經驗；個別名單請查原文 pp.130-139 ( PDF第156-165頁 )。

## Web Annex A-P

|          |          |
|----------|----------|
| A   認知活動 | B   社交活動 |
| C   飲食   | D   肥胖   |
| E   糖尿病  | F   高血壓  |
| G   聽力   | H   MHT  |
| I   憂鬱   | J   中風   |
| K   TBI  | L   視力   |
| M   睡眠   | N   HIV  |
| O   空污   | P   多領域  |

各 Web Annex 的 DOI 連結列於主文件 p.v ( PDF第7頁 )；主文件參考文獻為 pp.106-115 ( PDF第132-141頁 )。完整書目與授權已列於本手冊開頭。

原文定位 | WHO 2026, Annex 1 pp.116-129；Annex 2 pp.130-139；Web annexes p.140 ( PDF第142-168頁 )